

專業治療

- └─ 1. 骨水泥手術 | 椎體成形術與椎體撐開術
- └─ 2. 微創腰椎手術 | 內視鏡/顯微減壓與固定融合
- └─ 3. 微創頸椎手術 | 人工椎間盤置換與微創融合
- └─ 4. 腕隧道神經鬆解術 | 正中神經減壓治療
- └─ 5. 神經阻斷及疼痛介入治療 | 精準注射與疼痛控制
- └─ 6. 骨質疏鬆與骨折風險治療 | 骨密度管理與藥物治療

骨質疏鬆與骨折風險治療 | 骨密度管理與藥物治療

透過骨密度評估與個人化藥物治療，強化骨骼結構，降低再次骨折風險。

許多長輩是在輕微跌倒、彎腰搬東西、抱孫子，甚至只是用力咳嗽或打噴嚏後，突然出現劇烈腰背痛，檢查才發現是脊椎壓迫性骨折。

微創骨水泥或椎體撐開手術，可以幫助穩定這一次骨折、減少疼痛，讓患者有機會重新坐起、站立與行走。

但如果只處理這一次骨折，卻沒有治療背後的根本原因——骨質疏鬆症，未來仍可能發生第二次、第三次骨折。

治療重點在於：

手術處理眼前的骨折，骨鬆治療保護未來的骨頭。
治標也要治本，才能真正降低再次骨折與臥床風險。

骨質疏鬆不是只補鈣

骨質疏鬆常被稱為「沉默的疾病」，因為在骨折發生前，通常沒有明顯疼痛或症狀。

很多人以為骨質疏鬆只要多喝牛奶、吃鈣片就好。
但如果骨密度已經明顯不足，或已經發生過脊椎壓迫性骨折，單靠補鈣通常不夠。

完整治療需要評估：

- 骨密度狀況
- 是否曾經骨折
- 是否有脊椎壓迫性骨折
- 身高是否變矮、駝背是否加重
- 是否長期使用類固醇
- 腎功能、牙科狀況與其他疾病
- 跌倒風險與肌肉量

常見檢查包括：

- **DXA** 骨密度檢查
- **X** 光檢查
- 必要時安排 **MRI** 或 **CT**
- 抽血評估鈣質、維生素 D、腎功能與相關代謝問題

骨質疏鬆治療不是只看一張骨密度報告，而是要評估整體骨折風險。

骨質疏鬆藥物治療

骨質疏鬆藥物大致可分為兩大方向：

1. 減少骨質流失藥物

這類藥物可以降低骨頭被過度分解的速度，幫助穩定骨密度，減少骨折風險。

常見適合情況包括：

- 骨密度不足
- 停經後骨質流失
- 骨折風險升高
- 曾經發生脆弱性骨折
- 需要長期骨密度管理者

2. 促進骨質生成治療

如果骨質疏鬆較嚴重，或已經發生多次骨折、脊椎壓迫性骨折風險很高，就可能需要評估促進骨質生成治療。

這類治療的概念，是幫助骨頭重新建立更好的骨量與結構，常用於骨折風險較高或嚴重骨質疏鬆患者。

醫師會依照骨密度、骨折病史、年齡、腎功能、牙科狀況、健保條件與生活需求，安排最適合的治療計畫。

骨鬆藥物可以申請健保嗎？

可以評估。

目前部分骨質疏鬆治療藥物，在符合健保規範與臨床條件時，可以申請健保給付。

常見會評估的條件包括：

- 骨密度檢查結果
- 是否曾發生骨鬆性骨折
- 骨折部位與嚴重程度
- 是否屬於高骨折風險族群
- 過去用藥與治療反應
- 健保最新給付規範

也就是說，骨鬆治療不一定都要完全自費。

但每一種藥物的健保條件、治療期間與後續銜接方式都不同，不能只靠自己買鈣片或自行停藥。

在門診中，醫師會依照您的骨密度、影像檢查與骨折風險，協助評估是否符合健保用藥條件，並規劃後續追蹤。

如果已經發生脊椎壓迫性骨折怎麼辦？

如果已經發生脊椎壓迫性骨折，治療不只要處理骨密度，也要處理眼前的疼痛與骨折穩定性。

有些患者可以透過藥物、背架、休息與骨鬆治療改善。

但如果疼痛嚴重、長期臥床、保守治療效果有限，或椎體塌陷明顯，就需要進一步評估是否適合微創骨水泥、氣囊撐開或千斤頂椎體撐開手術。

骨水泥手術處理的是：

這一次疼痛的骨折。

骨質疏鬆治療處理的是：

避免下一次再骨折。

兩者一起規劃，才是完整治療。

什麼情況建議儘早評估骨鬆？

如果有以下情況，建議儘早安排骨質疏鬆與骨折風險評估：

- 65 歲以上女性或 70 歲以上男性
- 停經後女性
- 身高變矮，或駝背越來越明顯
- 曾因輕微跌倒、彎腰或咳嗽就骨折
- 父母曾有髖部或脊椎骨折病史
- 長期使用類固醇藥物
- 體重過輕、肌肉量不足
- 缺乏運動或少曬太陽
- 已知骨質疏鬆，但沒有規則治療
- 已發生脊椎壓迫性骨折，但尚未開始骨鬆治療

文宏裕醫師的治療觀點

在神經外科門診，我見過很多長輩因為一次輕微跌倒造成脊椎骨折，痛到無法翻身、坐起或下床。

透過微創骨水泥或椎體撐開手術，我們可以幫助長輩穩定骨折、減少疼痛，重新站起來。

但如果手術後就此打住，沒有好好治療背後脆弱的骨質，下一次骨折往往只是時間問題。

治標也要治本。

手術是把這一次倒下的牆穩住，骨鬆治療則是把牆壁內部的結構補強。

我不只關心您現在痛不痛，也關心未來五年、十年，您的骨頭能不能繼續支撐生活。

如果已經發生壓迫性骨折，或擔心自己有骨質疏鬆風險，就不要等到下一次骨折才開始處理。

讓專業醫師協助您評估骨密度、骨折風險、健保用藥條件與治療方式，建立完整的骨骼保護計畫。

手術不是目的，重新回到生活才是目的。

把時間留給生活，不留給疼痛。